

Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP)

1. Introducción y relevancia clínica

La **Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP)** corresponde a una **infección del tracto genital superior femenino** que compromete el **endometrio, trompas de Falopio, ovarios y estructuras pélvicas adyacentes**.

Su origen es habitualmente una **infección ascendente desde el cuello uterino o la vagina**, y constituye una de las **principales causas de infertilidad adquirida, embarazo ectópico y dolor pélvico crónico** en mujeres jóvenes.

En Chile, según el **MINSAL (Norma Técnica de ITS 2022)**, la EIP es considerada un **síndrome de manejo sindrómico obligatorio**, asociado principalmente a **infecciones por *Neisseria gonorrhoeae* y *Chlamydia trachomatis***, aunque la mayoría de los casos son **polimicrobianos**.

□ En EUNACOM se pregunta frecuentemente:

- “¿Cuál es la tríada diagnóstica clásica de EIP?”
 - “¿Qué esquema antibiótico usarías?”
 - “¿Cuáles son sus complicaciones a largo plazo?”
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Mecanismo de infección

1. **Etapas inicial:** infección cervical por gonococo o clamidia.
2. **Ascenso bacteriano:** hacia endometrio, trompas y ovarios.
3. **Inflamación y daño estructural:** cicatrización tubaria, adherencias y obstrucción.
4. **Complicaciones:** infertilidad, embarazo ectópico, dolor pélvico crónico, absceso tuboovárico.

b. Etiología bacteriana

Agente	Frecuencia / relevancia
<i>Chlamydia trachomatis</i>	30–50% de casos, causa de cuadros subclínicos
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	15–30%, inicio abrupto y purulento
Anaerobios (Bacteroides, Peptostreptococcus)	Flora ascendente polimicrobiana
<i>Mycoplasma genitalium</i>	Asociado a EIP leve o persistente
Enterobacterias	En usuarios de DIU o posparto

□ En usuarias de DIU, el riesgo de EIP se concentra en las **primeras 3 semanas postinserción**, luego se equipara al de la población general.

3. Clínica

a. Síntomas principales

- Dolor pélvico o abdominal bajo (bilateral).
- Flujo vaginal anormal o purulento.
- Fiebre (>38°C).
- Dispareunia o dolor postcoital.
- Náuseas y malestar general.

b. Signos al examen físico

- Dolor a la palpación de hipogastrio.

- Dolor a la movilización cervical (**signo de Chandelier**).
- Dolor anexial bilateral.
- Secreción cervical mucopurulenta.

c. Formas clínicas

- **Leve a moderada:** sin masa anexial ni signos sistémicos severos.
 - **Grave o complicada:** fiebre alta, vómitos, masa palpable (absceso tuboovárico).
 - **Subclínica:** dolor pélvico leve o asintomática (más frecuente en clamidia).
-

4. Diagnóstico

a. Diagnóstico clínico (criterios mínimos del CDC)

Debe sospecharse EIP en toda mujer sexualmente activa con **dolor pélvico o abdominal bajo, sin otra causa evidente, y al menos uno de los siguientes:**

1. Dolor a la movilización cervical.
2. Dolor uterino.
3. Dolor anexial.

Sensibilidad 90%, especificidad 50%: ante la duda, tratar.

b. Criterios de apoyo (aumentan especificidad)

- Temperatura $\geq 38^{\circ}\text{C}$.
- Leucocitosis o proteína C reactiva elevada.
- Secreción mucopurulenta cervical.
- Presencia de diplococos Gram (gonococo) o test positivo para clamidia.
- Ecografía con líquido libre pélvico o engrosamiento tubario.

c. Exámenes complementarios

Examen	Hallazgo
Hemograma	Leucocitosis moderada
PCR o VSG	Elevadas
Test de embarazo	Negativo (descartar ectópico)
Exudado endocervical	PCR para <i>N. gonorrhoeae</i> y <i>C. trachomatis</i>
Ecografía transvaginal	Engrosamiento tubario, líquido libre o absceso tuboovárico
Laparoscopia	Gold standard (no de rutina)

☐ El diagnóstico es **clínico**, y el tratamiento debe iniciarse **sin esperar confirmación microbiológica**.

5. Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencias clave
Embarazo ectópico	Amenorrea, test embarazo +
Apendicitis aguda	Dolor FID localizado, leucocitosis alta
Cistitis / Pielonefritis	Disuria, piuria sin dolor cervical

Endometriosis Dolor cíclico, sin fiebre

Torsión anexial Dolor súbito unilateral, masa palpable

6. Tratamiento (según MINSAL y CDC 2021)

a.

Casos leves o moderados (ambulatorios)

Esquema recomendado:

- **Ceftriaxona 500 mg IM dosis única**
 - **Doxiciclina 100 mg VO cada 12 h por 14 días**
 - **Metronidazol 500 mg VO cada 12 h por 14 días.**

☐ Añadir metronidazol cubre anaerobios y vaginosis asociada.
Control clínico a las 72 horas para verificar mejoría.

b.

Casos graves o hospitalización (criterios):

- Embarazo.
- Fiebre alta o vómitos.
- Masa anexial o absceso.
- Signos de sepsis.
- Falta de respuesta al tratamiento oral.
- Diagnóstico incierto.

Esquema hospitalario:

- **Ceftriaxona 1 g IV cada 24 h**
 - **Doxiciclina 100 mg IV/VO cada 12 h**
 - **Metronidazol 500 mg IV cada 12 h.**

Duración total: 14 días (puede continuar VO al alta).

c.

Alternativas:

- En alergia a beta-lactámicos:

Azitromicina 1 g VO semanal × 2 semanas + Metronidazol.

d.

Tratamiento de la pareja:

- Tratar a todas las parejas sexuales de los últimos 60 días.
 - Esquema: **Ceftriaxona 500 mg IM DU + Doxiciclina 100 mg VO c/12h × 7 días.**
 - Abstinencia sexual hasta completar tratamiento.
-

7. Complicaciones

Tipo	Descripción
Infertilidad tubaria	Cicatrización y obstrucción tubaria → 10–20% tras EIP.
Embarazo ectópico	Riesgo ×6–10 por daño tubario.

Dolor pélvico crónico

Secuela fibrosa en 15–25%.

Absceso tuboovárico

Masa inflamatoria purulenta → requiere drenaje y antibióticos IV.

Recurrencia

Hasta 25% de las mujeres por reinfección (clamidia).

☐ La prevención y tratamiento precoz son claves para evitar infertilidad y embarazos ectópicos.

8. Prevención

- Tamizaje y tratamiento oportuno de ITS (clamidia/gonorrea).
 - Uso sistemático de preservativo.
 - Educación sexual integral.
 - Control de contactos sexuales.
 - Inserción de DIU bajo condiciones asépticas.
 - Revisión postinserción del DIU si hay síntomas.
-

9. Manejo del absceso tuboovárico

- Hospitalización y antibióticos IV.
 - Si no mejora en 72 h: drenaje guiado por imagen o cirugía.
 - No extraer DIU durante fase aguda, salvo sepsis o absceso persistente.
 - En postmenopáusicas: descartar neoplasia.
-

10. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Tríada diagnóstica clásica:** dolor pélvico + fiebre + dolor a la movilización cervical.
2. **Diagnóstico clínico:** iniciar antibióticos ante sospecha.
3. **Tratamiento estándar:** Ceftriaxona + Doxiciclina + Metronidazol × 14 días.
4. **Tratar pareja sexual** en todos los casos.
5. **Complicaciones:** infertilidad, embarazo ectópico, absceso tuboovárico.
6. **No retirar el DIU** si EIP leve y paciente estable.
7. **Seguimiento a 72 h:** si no mejora, hospitalizar.



Errores comunes

- Esperar resultados de laboratorio antes de iniciar tratamiento.
- Omitir metronidazol en el esquema.
- No tratar pareja sexual.
- Retirar DIU innecesariamente.
- Confundir EIP con apendicitis sin descartar ITS.

11. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **EIP** es una infección ascendente del tracto genital superior, principalmente por **clamidia y gonococo**.
2. **Diagnóstico clínico:** dolor pélvico + sensibilidad cervical o anexial.

3. **Tratamiento empírico inmediato:** Ceftriaxona + Doxiciclina + Metronidazol × 14 días.
4. **Tratar pareja sexual** y abstinencia hasta finalizar terapia.
5. **Complicaciones:** infertilidad, embarazo ectópico, dolor crónico, absceso tuboovárico.
6. **Hospitalizar** si embarazo, fiebre alta, absceso o falta de respuesta.
7. **Prevención:** uso de preservativo, tamizaje ITS y educación sexual.